



ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOTACJĘ

Aplikacja pacjenta „Wyjątkowe Serca”

Opis i założenia projektu. Mobilna aplikacja wspierająca rodziców i opiekunów dzieci z wrodzonymi wadami serca: profil medyczny, leki i przypomnienia dawek, pomiary, historia INR oraz bezpieczne udostępnianie danych w rodzinie.

PLATFORMY	CENA DLA RODZIN	DLA KOGO	STATUS
Android + iOS	aplikacja bezpłatna	rodziny dzieci z WWS	wersja robocza gotowa

Charakter dokumentu. Niniejszy załącznik opisuje cele, zakres funkcjonalny, założenia techniczne i organizacyjne, ochronę danych o zdrowiu oraz powiązanie prac z kosztorysem wniosku. Projekt dotyczy dokończenia, publikacji w sklepach, dostosowania do wymogów RODO oraz utrzymania aplikacji pacjenta. Prace opierają się na istniejącym zapleczu cyfrowym fundacji (serwis, API, logika aplikacji pacjenta), a nie na budowie całego ekosystemu od zera.

O fundacji

Fundacja Wyjątkowe Serca (KRS 0001072904, NIP 7011177987; siedziba: Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa) działa od grudnia 2023 r. i została założona przez rodziców dzieci z wrodzonymi wadami serca. Fundacja wspiera rodziny od diagnozy, przez leczenie, po rehabilitację: prowadzi zbiórki na rzecz podopiecznych, organizuje wydarzenia charytatywne dla małych pacjentów oraz dzieli się praktyczną wiedzą wynikającą z doświadczeń własnych rodziców. Merytorycznie fundację wspiera Rada Naukowa złożona z lekarzy kardiologów, kardiochirurgów i perinatologów. Statut i sprawozdania finansowe są publikowane w serwisie internetowym fundacji. Aplikacja pacjenta, której dotyczy niniejszy dokument, jest rozszerzeniem tej działalności statutowej o narzędzie cyfrowe.

Dokument w skrócie

Produkt	Bezpłatna aplikacja mobilna (Android + iOS) dla rodziców i opiekunów dzieci z WWS.
Zakres projektu	Dokończenie aplikacji, publikacja w Google Play i App Store, zgodność z RODO, utrzymanie przez 12 miesięcy.
Wnioskowana kwota	228 400 zł , w tym: rozwój aplikacji 155 100 zł (705 h × 220 zł/h), koszty stałe okresu prac 7 000 zł oraz utrzymanie przez 12 miesięcy po wdrożeniu 66 300 zł.
Dane o zdrowiu	Art. 9 RODO: wyraźne zgody, ocena skutków (DPIA), przetwarzanie w UE.
Wkład własny	Prace wykonane nieodpłatnie przed projektem: 121 000 zł (ok. 44% zakresu). Wartość gotowej aplikacji to 276 100 zł = 121 000 zł wkładu własnego + 155 100 zł rozwoju z dotacji; utrzymanie i koszty stałe liczone są osobno.

Spis treści

1. Cel projektu i grupa docelowa
 2. Problem i uzasadnienie
 3. Zakres funkcjonalny wersji 1 (v1) i poza zakresem
 4. Przepływ użytkownika
 5. Platformy, sklepy i architektura
 6. Ochrona danych osobowych i danych o zdrowiu (RODO)
 7. Harmonogram i kamienie milowe
 8. Powiązanie z budżetem projektu
 9. Utrzymanie po wdrożeniu
 10. Oczekiwane efekty i mierniki (ostrożne szacunki)
 11. Podsumowanie
- Załącznik A. Podgląd aplikacji (wersja robocza)

1 Cel projektu i grupa docelowa

Celem projektu jest udostępnienie rodzicom i opiekunom dzieci z wrodzonymi wadami serca (WWS) wygodnej, bezpiecznej aplikacji mobilnej, która w jednym miejscu gromadzi najważniejsze informacje o stanie zdrowia dziecka, potrzebne w codziennej opiece i na wizytach lekarskich: profil medyczny, leki i przypomnienia dawek, pomiary (m.in. saturacja, tętno, ciśnienie, diureza), historię badań INR oraz eksport czytelnego raportu PDF.

Aplikacja jest elementem misji Fundacji Wyjątkowe Serca, czyli wspierania rodzin na ścieżce leczenia, a nie zastępowania personelu medycznego. Narzędzie ma charakter rejestru i asystenta organizacyjnego prowadzonego przez opiekuna, a nie systemu diagnostycznego ani dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy.

Główna grupa docelowa

- rodzice i opiekunowie prawni dzieci z wrodzonymi wadami serca;
- nastoletni pacjenci (od ok. 16 lat), samodzielnie korzystający z aplikacji pod opieką rodziny, przygotowujący się do przejęcia odpowiedzialności za własne leczenie;
- osoby współopiekujące się dzieckiem (np. drugi rodzic, babcia/dziadek), którym właściciel konta świadomie udostępni dostęp do tych samych danych;
- fundacja jako podmiot udostępniający narzędzie w ramach działalności statutowej (bez monetyzacji danych).

Usamodzielnianie nastoletnich pacjentów

Aplikacja pomaga wyrobić dobre nawyki u nastolatków: uczy pilnowania dawek leków, regularnych pomiarów i prowadzenia własnej historii leczenia. Celem jest przygotowanie pacjenta do samodzielnej opieki nad swoim zdrowiem po ukończeniu 18 lat, gdy przechodzi spod opieki pediatrycznej pod opiekę placówki dla dorosłych. Środowisko kardiologii dziecięcej nazywa ten moment najłagodniejszym punktem systemu: rodziny bywają zagubione, nie wiedzą, kto odpowiada za dalsze leczenie, jakie obowiązują procedury i gdzie szukać pomocy, a część pacjentów wypada wtedy z regularnej obserwacji kardiologicznej. Prowadzona w aplikacji historia leczenia, hospitalizacji i dokumentacji jest w takiej sytuacji kompletem informacji, który pacjent zabiera ze sobą do nowego ośrodka. Po osiągnięciu pełnoletności przejmuje on kontrolę nad kontem i sam decyduje, czy zachować rodzicom dostęp do swoich danych (rozdz. 6).

Język i dostępność

Interfejs aplikacji jest w języku polskim. Aplikacja działa na popularnych smartfonach z systemem Android; w ramach projektu finalizowana jest także publikacja na iOS, aby nie wykluczać rodzin korzystających z iPhone'ów. Interfejs projektowany jest z dbałością o czytelność (wyraźne kontrasty, duże elementy dotykowe, prosta nawigacja), a uwagi dotyczące dostępności zgłaszane przez użytkowników będą obsługiwane w ramach utrzymania.

2 Problem i uzasadnienie

Wrodzone wady serca są najczęstszymi z wad wrodzonych. W Polsce co roku rodzi się ok. 3 tys. dzieci z WWS (ok. 1% urodzeń). Rodziny dzieci z WWS na co dzień zarządzają dużą ilością informacji medycznych: harmonogramami leków (często z różnymi dawkami i częstotliwościami), wynikami INR istotnymi przy leczeniu przeciwkrzepliwym, pomiarami domowymi, historią leczenia i kolejnych hospitalizacji oraz dokumentacją medyczną z wypisów i konsultacji. W praktyce dane te są rozproszone w notesach, zdjęciach wyników, arkuszach kalkulacyjnych i pamięci opiekunów. Utrudnia to przygotowanie do wizyty, przekazanie informacji drugiemu opiekunowi oraz zachowanie ciągłości opieki przy zmianie osoby sprawującej pieczę.

Istnieją ogólne aplikacje zdrowotne i notatniki, jednak nie są one dopasowane do specyfiki opieki nad dzieckiem z wadą serca (INR, leki z przypomnieniami, historia hospitalizacji, udostępnianie w rodzinie, eksport karty na wizytę). Fundacja dysponuje już zapleczem cyfrowym (strona, API, logika aplikacji pacjenta). Projekt dotacyjny pozwala ukończyć wersję mobilną, opublikować aplikację w oficjalnych sklepach, wzmocnić ochronę danych o zdrowiu oraz zapewnić rok stabilnego utrzymania.

Dlaczego aplikacja mobilna? Opiekunowie korzystają ze smartfona w szpitalu, w domu i w drodze. Aplikacja mobilna umożliwia m.in. lokalne przypomnienia o dawkach i pomiarach, wygodne wprowadzanie danych oraz udostępnianie raportu PDF lekarzowi bez konieczności logowania się do wersji przeglądarkowej w trudnych warunkach.

3 Zakres funkcjonalny wersji 1 (v1) i poza zakresem

3.1. Zakres v1: co już działa, a co powstanie w projekcie

Tabela rozdziela dwie rzeczy: funkcje gotowe i przetestowane w roboczej wersji aplikacji (zrzuty ekranu w załączniku A), wytworzone nieodpłatnie jako wkład własny fundacji, oraz prace, które zostaną wykonane ze środków dotacji. Kolumna środkowa odpowiada ok. 44% docelowego zakresu produktu i podstawie wyceny wkładu własnego (rozdz. 8).

Obszar	Co już działa (wkład własny fundacji)	Co powstanie ze środków dotacji
Logowanie i konta	Logowanie kontem Google bez osobnego hasła; token sesji weryfikowany po stronie API.	Dostosowanie logowania do wymagań App Store, jednolity model sesji na Androidzie i iOS.
Profil pacjenta	Imię i nazwisko, grupa krwi; słownik 51 wad serca z wyszukiwaniem i wielokrotnym wyborem; zaburzenia rytmu (9 typów z opisem), rozrusznik (7 rodzajów), przebyte operacje (typ, data, liczba dni na intensywnej terapii), powikłania, choroby współistniejące, zespoły genetyczne; zapis automatyczny.	Panel danych opiekunów i rodziców, uzupełnienie słownika wad serca, przejście konta przez pacjenta po 18. roku życia.
Historia leczenia i hospitalizacji	Funkcja nie istnieje.	Rejestr pobytów szpitalnych i etapów leczenia (daty, placówka, powód, przebieg) jako oś czasu dostępna na wizycie i przy zmianie ośrodka.
Dokumentacja medyczna	Funkcja nie istnieje.	Wgrywanie dokumentów PDF (wypisy, wyniki, konsultacje) z datą dokumentu, limit wielkości pliku, wgrywanie dostępne dla kont zatwierdzonych przez fundację, bezpieczne przechowywanie.
Leki	Lista leków z dawką, częstotliwością (od co 4 godziny do co 2 dni) i czasem trwania; harmonogram i historia podań, śledzenie kolejnej dawki, lokalne przypomnienia na urządzeniu.	Przypomnienia na iOS, obsługa sytuacji brzegowych, testy na urządzeniach.
Pomiary	Saturacja, tętno, ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, diureza dobową, notatki; historia wpisów z oznaczeniem wartości odbiegających od normy, wykresy trendów (od 7 dni do całego okresu), codzienne przypomnienie o pomiarze.	Dopracowanie wykresów i interfejsu, testy na urządzeniach.
INR	Rejestr wyników z czasem protrombinowym, normą laboratorium i wskaźnikiem ISI; historia wyników, zakresy odniesienia o charakterze informacyjnym.	Stabilizacja modułu i ujednolicenie opisów (rejestr wyników, nie narzędzie diagnostyczne).
Raport PDF	Eksport karty pacjenta z urządzenia: profil, leki, pomiary z wykresami oraz INR z tabelą parametrów badania.	Uzupełnienie raportu o hospitalizację i dokumentację, dopracowanie wydruku.
Udostępnianie w rodzinie	Zaproszenie dla współopiekuna (token z terminem ważności), akceptacja zaproszenia, lista osób z dostępem, odwoływanie dostępu.	Komunikaty informacyjne przy zaproszeniu (zakres udostępnianych danych), testy.
Zaplecze: API, baza, chmura	API fundacji obsługujące profil, leki, pomiary, INR oraz dostęp; baza danych w regionie UE, uwierzytelnianie, kopie zapasowe; ta sama logika w wersji webowej.	Wzmocnienie zabezpieczeń, limity zapytań i wgrywanych plików, dziennik dostępu, usuwanie konta i danych w całym systemie.
Ochrona danych (RODO)	Dostęp do danych wyłącznie po zalogowaniu, połączenia szyfrowane, przetwarzanie w infrastrukturze w UE.	Wyraźne zgody na dane o zdrowiu (art. 9), aktualizacja polityki prywatności, prawo do usunięcia konta, ocena skutków (DPIA), dziennik dostępu.
Aplikacja mobilna i publikacja	Wersja robocza na Androida (React Native) z kompletem powyższych ekranów, przed publikacją w sklepie.	Stabilizacja, wersja iOS, testy z rodzinami, złożenie i weryfikacja w Google Play oraz App Store, materiały informacyjne.
Utrzymanie	Prowadzone doraźnie, bez wynagrodzenia.	Dwanaście miesięcy utrzymania po wdrożeniu: aktualizacje systemów, poprawki, monitoring, wsparcie fundacji (rozdz. 9).

3.2. Poza zakresem v1

- diagnostyka medyczna, zalecenia terapeutyczne generowane automatycznie, „aplikacja medyczna” w rozumieniu wyrobu medycznego;
- panel lekarza / placówki medycznej, integracja z systemami P1 / e-dokumentacją medyczną podmiotów leczniczych;
- publiczna strona fundacji, sklep charytatywny i płatności darowizn (istnieją osobno; nie są przedmiotem tej linii budżetowej);
- kalendarz i zapisy na konsultacje psychologiczne w aplikacji (wybór wolnego terminu przez rodzica), planowany kierunek rozwoju po v1;
- przekazywanie zanonimizowanych danych medycznych do celów naukowych, rozważane w kolejnym etapie, wymaga odrębnej analizy prawnej i osobnej, dobrowolnej zgody;
- tryb offline z pełną synchronizacją konfliktów (może być rozważany w przyszłości);
- powiadomienia push wysyłane z serwera; w v1 przypomnienia działają lokalnie na urządzeniu;
- wersje językowe inne niż polski.

Świadome ograniczenie zakresu pozwala ukończyć produkt użyteczny dla rodzin, bezpieczny pod kątem danych o zdrowiu i możliwy do utrzymania przez fundację.

4 Przepływ użytkownika

Poniższy opis oddaje docelowy przebieg korzystania z aplikacji po publikacji w sklepach (z uwzględnieniem prac RODO i iOS przewidzianych w projekcie).

Krok	Działanie użytkownika	Wynik
1	Logowanie (Google lub Apple, zależnie od platformy); akceptacja regulaminu / zgód RODO (w tym na dane o zdrowiu)	Utworzenie lub odtworzenie sesji; wejście do aplikacji
2	Uzupełnienie profilu pacjenta (dane medyczne istotne dla opieki)	Zapis w bezpiecznym magazynie danych powiązany z kontem
3	Dodawanie leków, oznaczanie dawek; włączenie przypomnień (opcjonalnie)	Lokalne powiadomienia systemowe; historia podań
4	Wprowadzanie pomiarów i wyników INR	Historia, wykresy, etykiety informacyjne
5	Eksport raportu PDF na wizytę lub do drugiego opiekuna	Plik PDF do udostępnienia z urządzenia
6	Utworzenie zaproszenia dla współopiekuna; druga osoba akceptuje link z zaproszenia	Wspólny dostęp do danych; możliwość odwołania dostępu przez właściciela

Główne obszary nawigacji (zakładki)

- **Profil pacjenta** – dane stałe, historia operacji / wad, panel opiekunów;
- **Historia leczenia i hospitalizacji** – oś czasu pobytów szpitalnych wraz z dołączoną dokumentacją medyczną (PDF);
- **Leki** – farmakoterapia i przypomnienia;
- **Pomiary** – rejestr parametrów domowych;
- **INR** – historia badań przeciwwkrzepliwych;
- oraz ścieżki pomocnicze: logowanie, akceptacja zaproszenia, eksport PDF, zarządzanie dostępami.

5 Platformy, sklepy i architektura

5.1. Platformy i dystrybucja

Element	Założenie
Android	Aplikacja pacjenta w sklepie z aplikacjami Google Play; konto deweloperskie fundacji; opłata rejestracyjna sklepu jest jednorazowa.
iOS	Ta sama baza funkcjonalna; logowanie Apple; testy przedpremierowe i publikacja w App Store z konta deweloperskiego fundacji.

Element	Założenie
Cena dla użytkownika	Aplikacja bezpłatna : pobranie i pełne korzystanie bez opłat. Brak zakupów w aplikacji, subskrypcji, reklam i jakiegokolwiek sprzedaży wewnątrz aplikacji; wzmianki o „sklepach” w tym dokumencie dotyczą wyłącznie sklepów z aplikacjami (Google Play, App Store).
Materiały w sklepach	Opisy i materiały po polsku; polityka prywatności i zastrzeżenie medyczne dostępne przed pobraniem aplikacji.

5.2. Architektura (zarys dla recenzenta, bez szczegółów wdrożeniowych)

Aplikacja mobilna komunikuje się z własnym API fundacji, utrzymywanym w chmurze w regionie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uwierzelnianie opiera się na logowaniu przez zaufanego dostawcę tożsamości (token sesji weryfikowany po stronie API). Dane medyczne są zapisywane w bazie po stronie serwera i nie są publicznie dostępne bez zalogowania. Warstwa serwisowa jest współdzielona z istniejącym zapleczem cyfrowym fundacji, co ogranicza koszt i ryzyko dublowania infrastruktury.

Model dostępu: urządzenie użytkownika → szyfrowane połączenie HTTPS → API (weryfikacja tokenu) → magazyn danych w UE. Klienci mobilni i webowi nie uzyskują bezpośredniego, otwartego dostępu do całej bazy, a jedynie do zasobów wynikających z tożsamości i ewentualnego udostępnienia w rodzinie.

Technicznie aplikacja mobilna jest rozwijana w podejściu wieloplatformowym (wspólna logika biznesowa dla Android i iOS), co pozwala utrzymać jednakowy zestaw funkcji przy rozsądnym koszcie drugiej platformy oraz zachować bezpieczeństwo i utrzymalność rozwiązania.

6 Ochrona danych osobowych i danych o zdrowiu (RODO)

Aplikacja przetwarza **dane o zdrowiu** (szczególna kategoria danych w rozumieniu art. 9 RODO): m.in. informacje o wadach serca, lekach, pomiarach, wynikach INR, przebiegu leczenia i hospitalizacji oraz wgrzywaną dokumentację medyczną. Z tego względu projekt przewiduje środki wyższe niż przy zwykłych danych kontaktowych.

6.1. Podstawa i transparentność

- administrator danych: Fundacja Wyjątkowe Serca (dane rejestrowe i kontakt RODO w polityce prywatności);
- podstawa: świadczenie usługi aplikacji (art. 6 RODO) oraz **wyraźna zgoda** na przetwarzanie danych o zdrowiu (art. 9 ust. 2 lit. a), zbierana w aplikacji w sposób oddzielny od marketingu;
- informacja o roli opiekuna prawnego przy danych dziecka;
- polityka prywatności zaktualizowana pod aplikację pacjenta, dostępna w aplikacji i w opisach sklepowych;
- jasna informacja przy zaproszeniu współopiekuna: druga osoba uzyska wgląd w pełny zakres danych medycznych udostępnionego profilu.

6.2. Środki techniczne i organizacyjne (w projekcie)

Obszar	Założenie w projekcie
Dostęp	Wyłącznie po zalogowaniu; autoryzacja po stronie API; brak publicznego odczytu kart pacjentów.
Szyfrowanie	Połączenia HTTPS; szyfrowanie danych w spoczynku po stronie dostawcy chmury w UE.
Region	Przetwarzanie w infrastrukturze w regionie EOG (centrum danych w UE).
Kopie zapasowe	Regularne kopie zapasowe bazy (retencja krótko- i średnioterminowa wg konfiguracji chmury).
Zabezpieczenia API	Ograniczenie publicznie zbędnej dokumentacji API, ochrona sekretów, limity zapytań, zawężenie uprawnień kont serwisowych.
Rozliczalność	Podstawowy dziennik zdarzeń dostępu (kto / kiedy / jaki zasób, bez zbędnego logowania treści klinicznej).
Prawa osoby	Podgląd i edycja własnych danych w aplikacji; usunięcie konta i powiązanych danych medycznych jako funkcja docelowa v1; eksport raportu PDF jako forma przenoszenia informacji na wizytę.
Dokumentacja medyczna	Wgrzywanie plików wyłącznie przez zalogowanych użytkowników zatwierdzonych przez fundację; limit wielkości pliku; pliki przechowywane w tym samym reżimie bezpieczeństwa co pozostałe dane o zdrowiu.
Pełnoletność pacjenta	Po ukończeniu 18 lat dostęp rodziców zostaje wstrzymany; dalszy wgląd wymaga wyraźnej zgody pacjenta, którą może on w każdej chwili wycofać.

Obszar	Założenie w projekcie
Ocena ryzyka	Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) dla przetwarzania danych o zdrowiu w aplikacji pacjenta.
Podmioty przetwarzające	Umowy / warunki powierzenia z dostawcami chmury i tożsamości (dostawcy infrastruktury w UE); po stronie fundacji.

Zastrzeżenie medyczne. Aplikacja nie stawia diagnoz i nie zastępuje konsultacji lekarskiej. Moduł INR i etykiety wynikowe mają charakter pomocniczy / edukacyjny. Sformułowania w interfejsie i w opisach sklepowych będą spójne z tą zasadą, aby nie wprowadzać użytkowników w błąd co do charakteru narzędzia.

7 Harmonogram i kamienie milowe

Poniższy harmonogram ma charakter roboczy (miesiące od startu finansowania). Część prac produktowych jest już zaawansowana; projekt koncentruje się na ukończeniu prac, zgodności, publikacji i utrzymaniu. Prace rozwojowe rozłożone są na osiem miesięcy (ok. 100 godzin miesięcznie, czyli ok. 5 godzin dziennie), a dwunastomiesięczny okres utrzymania zaczyna się dopiero po ich zakończeniu i publikacji aplikacji.

Faza	Czas	Kamienie milowe
F1. Analiza i doprecyzowanie zakresu	Miesiąc 1	Utrwalenie założeń (niniejszy opis), priorytety RODO i sklepów, plan testów na urządzeniach.
F2. Produkt Android + iOS	Miesiące 1–5	Ukończenie funkcji v1, logowanie Apple, testy na urządzeniach, stabilizacja.
F3. RODO i bezpieczeństwo	Miesiące 3–6	Zgody art. 9, usuwanie konta, wzmocnienie zabezpieczeń API, dziennik dostępu, ocena skutków (DPIA), aktualizacja polityki.
F4. Publikacja w sklepach	Miesiące 6–8	Konta deweloperskie fundacji, karty sklepowe PL, weryfikacja w Google Play i App Store, poprawki po weryfikacji.
F5. Utrzymanie po wdrożeniu	Miesiące 9–20	Dwanaście miesięcy liczonych od zakończenia prac i publikacji: aktualizacje systemów, poprawki, monitoring hostingu, wsparcie fundacji (rozdz. 9).

Ryzyka i ich ograniczanie

Ryzyko	Sposób ograniczania
Wydłużona weryfikacja aplikacji przez sklepy (szczególnie App Store przy treściach zdrowotnych)	Bufor na poprawki w harmonogramie; zastrzeżenie medyczne i polityka prywatności przygotowane przed zgłoszeniem.
Brak zwolnienia z opłaty Apple Developer dla organizacji non-profit	Koszt awaryjny (ok. 500 zł/rok) możliwy do pokrycia w ramach środków utrzymaniowych.
Niska adopcja narzędzia przez rodziny	Aplikacja bezpłatna; promocja kanałami fundacji (rozdz. 10); rozwój na podstawie opinii rodzin.
Ograniczona dostępność wykonawcy	Wykonawca jest autorem wersji roboczej (pełna znajomość kodu); harmonogram z buforami; kod w repozytorium fundacji.
Zmiany wymogów sklepów lub przepisów	Dwunastomiesięczne utrzymanie obejmuje aktualizacje zgodnościowe.

8 Powiązanie z budżetem projektu

Poniższa tabela łączy bloki merytoryczne z kosztorysem wniosku. **Stawka referencyjna prac programistycznych: 220 zł/h.** W budżecie nie ujęto kosztów narzędzi warsztatu wykonawcy (środowisko programistyczne, oprogramowanie wspomagające prace deweloperskie itp.); są one wliczone w stawkę. Ujęto koszty bezpośrednio związane z produktem fundacji: prace, RODO, hosting, opłaty sklepowe.

Lp.	Pozycja	Godz.	Kwota (zł)
A. Rozwój aplikacji (pozostały zakres)			
1	Analiza i projekt rozszerzonego zakresu funkcjonalnego	30	6 600
2	Dokończenie i stabilizacja aplikacji Android: obsługa błędów, testy na urządzeniach, dopracowanie interfejsu (profil, leki, pomiary, INR, raport PDF, udostępnianie)	145	31 900
3	Dokumentacja medyczna: wgrywanie plików PDF z datą dokumentu, limity wielkości, zatwierdzanie użytkowników, bezpieczne przechowywanie	60	13 200
4	Panel danych opiekunów oraz historia leczenia i hospitalizacji	70	15 400
5	Usamodzielnienie pacjenta po 18. roku życia (przejęcie konta, zgody na dostęp rodziców)	30	6 600
6	Testy z rodzinami-testerami przed publikacją; poprawki po testach	30	6 600
7	Implementacja i testy iOS	95	20 900
8	Publikacja w Google Play i App Store (materiały, zastrzeżenie medyczne) oraz materiały informacyjne dla rodzin	40	8 800
Suma A		500	110 000
B. Zgodność RODO / dane o zdrowiu			
9	Zgody art. 9, dane opiekunów, polityka prywatności pod aplikację, komunikaty przy zaproszeniach	60	13 200
10	Usunięcie konta i danych w całym systemie (API, web, aplikacja mobilna) wraz z testami kasowania kaskadowego	50	11 000
11	Wzmocnienie zabezpieczeń API (sekrety, limity zapytań i uploadu, konta serwisowe)	45	9 900
12	Dziennik dostępu, ocena skutków (DPIA), testy zgodności	50	11 000
Suma B		205	45 100
C. Koszty stałe w okresie prac			
13	Konsultacja / przegląd dokumentacji RODO (prawnik)	–	3 000
14	Hosting i chmura w okresie prac nad aplikacją	–	4 000
Suma C		–	7 000
D. Utrzymanie po wdrożeniu (12 miesięcy)			
15	Ryczałt on-call: 3 000 zł × 12 mies. za gotowość programisty, czasy reakcji (SLA), monitoring oraz do 10 h prac utrzymaniowych miesięcznie w cenie	120	36 000
16	Pula godzin ponad ryczałt, uruchamiana na zlecenie fundacji (110 h × 220 zł/h)	110	24 200
17	Hosting i chmura (API, baza, kopie zapasowe, przechowywanie dokumentacji PDF) przy założeniu ok. 100 aktywnych kont	–	6 000
18	Google Play Console (opłata jednorazowa)	–	100
19	Apple Developer Program (zwolnienie z opłaty dla organizacji non-profit, założenie)	–	0
Suma D		230	66 300
RAZEM: WNIOSKOWANA DOTACJA		935	228 400

Jak czytać powyższe kwoty

Składnik	Kwota
Prace rozwojowe (bloki A i B) — finansowane z dotacji	155 100 zł
Koszty stałe okresu prac (blok C) — finansowane z dotacji	7 000 zł
Utrzymanie przez 12 miesięcy po wdrożeniu (blok D) — z dotacji	66 300 zł
Razem: wnioskowana dotacja	228 400 zł
Wkład własny fundacji: prace wykonane przed projektem, poza dotacją	121 000 zł
Wartość gotowej aplikacji (prace rozwojowe + wkład własny)	276 100 zł

Wartość gotowej aplikacji obejmuje wyłącznie prace nad produktem: 121 000 zł, które fundacja wniosła nieodpłatnie (ok. 550 h, ok. 44% zakresu — wykaz funkcji w rozdz. 3), oraz 155 100 zł prac pozostałych do wykonania. Utrzymanie i koszty stałe okresu prac są kosztem eksploatacji, dlatego nie wchodzi do wartości produktu. Autor wersji roboczej zrealizuje także prace objęte kosztorysem, co ogranicza ryzyko wdrożenia.

Mapowanie opisu → budżet

Część opisu projektu	Pozycje kosztorysu
Niniejszy dokument / analiza i projekt (rozdz. 1–5, 7)	Lp. 1
Zakres v1 Android, przepływ, funkcje medyczne, testy z rodzinami	Lp. 2–6
iOS, sklepy, zastrzeżenie medyczne, materiały dla rodzin (rozdz. 10)	Lp. 7–8
Ochrona danych (rozdz. 6)	Lp. 9–13
Utrzymanie, hosting i infrastruktura (rozdz. 9)	Lp. 14–19

Szczegółowy kosztorys w formularzu wniosku powinien być tożsamy z powyższymi kwotami.

9 Utrzymanie po wdrożeniu

Publikacja w sklepach nie kończy odpowiedzialności za narzędzie przetwarzające dane o zdrowiu. W ramach 12 miesięcy projektu przewidziano aktualizacje pod nowe wersje systemów Android i iOS, usuwanie zgłaszanych błędów, utrzymanie hostingu API i bazy wraz z kopiami zapasowymi, drobne zmiany interfejsu i treści (w tym komunikaty RODO) oraz wsparcie fundacji w komunikacji z rodzinami, zgodnie z zakresem z rozdz. 3 i pozycjami 15–19 kosztorysu. Okres utrzymania liczy się od zakończenia prac nad aplikacją, a nie od startu projektu.

Model rozliczenia. Utrzymanie opiera się na ryczałcie miesięcznym (3 000 zł) za gotowość programisty. Ryczałt obejmuje uzgodnione czasy reakcji (SLA), monitoring, kopie zapasowe oraz do 10 godzin prac miesięcznie. Prace ponad ten limit rozliczane są ze wskazanej w kosztorysie puli 110 godzin (220 zł/h), uruchamianej wyłącznie na pisemne zlecenie fundacji. Dzięki temu fundacja ma przewidywalny koszt stały, zagwarantowaną dostępność wykonawcy oraz z góry określony limit wydatków na prace nieplanowane.

- **Czasy reakcji (SLA):** awaria krytyczna (aplikacja niedostępna, incydent bezpieczeństwa): reakcja w 1 dzień roboczy, rozwiązanie lub obejście w 3 dni; pozostałe zgłoszenia do 5 dni roboczych;
- **w ryczałcie:** aktualizacje pod nowe wersje Android/iOS i zależności, poprawki błędów, monitoring dostępności, kopie zapasowe, drobne zmiany treści i komunikatów RODO;
- **poza ryczałtem:** nowe moduły i funkcje, wyceniane odrębnie, poza budżetem projektu.

Model długoterminowy: fundacja pozostaje właścicielem kont sklepowych, polityk i relacji z użytkownikami; prace programistyczne mogą być kontynuowane w trybie utrzymaniowym po zakończeniu okresu dotacji.

10 Oczekiwane efekty i mierniki (ostrożne szacunki)

Projekt ma charakter wsparcia organizacyjnego i informacyjnego dla rodzin, a nie interwencji medycznej. Poniższe mierniki służą rozliczeniu działania narzędzia cyfrowego, bez obietnic skutków klinicznych.

Obszar	Przykładowy miernik	Uwagi
Dostępność	Publikacja w Google Play i (docelowo) App Store; aplikacja bezpłatna	Tak / nie + data publikacji
Zasięg	Co najmniej 200 instalacji i 100 aktywnych kont w 12 mies. od publikacji	Wartości docelowe ostrożne; wynik zależny od promocji fundacji
Użyteczność	Korzystanie z głównych funkcji (profil, leki, pomiary/INR, PDF)	Na podstawie statystyk zagregowanych, bez treści medycznej w raportach publicznych
Bezpieczeństwo / RODO	Wdrożone zgody, usuwanie konta, zaktualizowana polityka, DPIA	Lista kontrolna ukończenia fazy F3

Wsparcie psychologiczne. Rodziny, które fundacja pozna dzięki aplikacji, uzyskują dostęp do **bezpłatnych konsultacji psychologicznych** prowadzonych w ramach działalności statutowej fundacji. Narzędzie cyfrowe pełni tu funkcję pomostu: pozwala dotrzeć ze wsparciem do rodzin, które inaczej pozostałyby poza zasięgiem fundacji.

Dotarcie do rodzin. Aplikacja będzie promowana kanałami własnymi fundacji (serwis internetowy, media społecznościowe, społeczność podopiecznych i ich rodzin) oraz przez materiały informacyjne przekazywane rodzicom, m.in. w ośrodkach kardiologii dziecięcej.

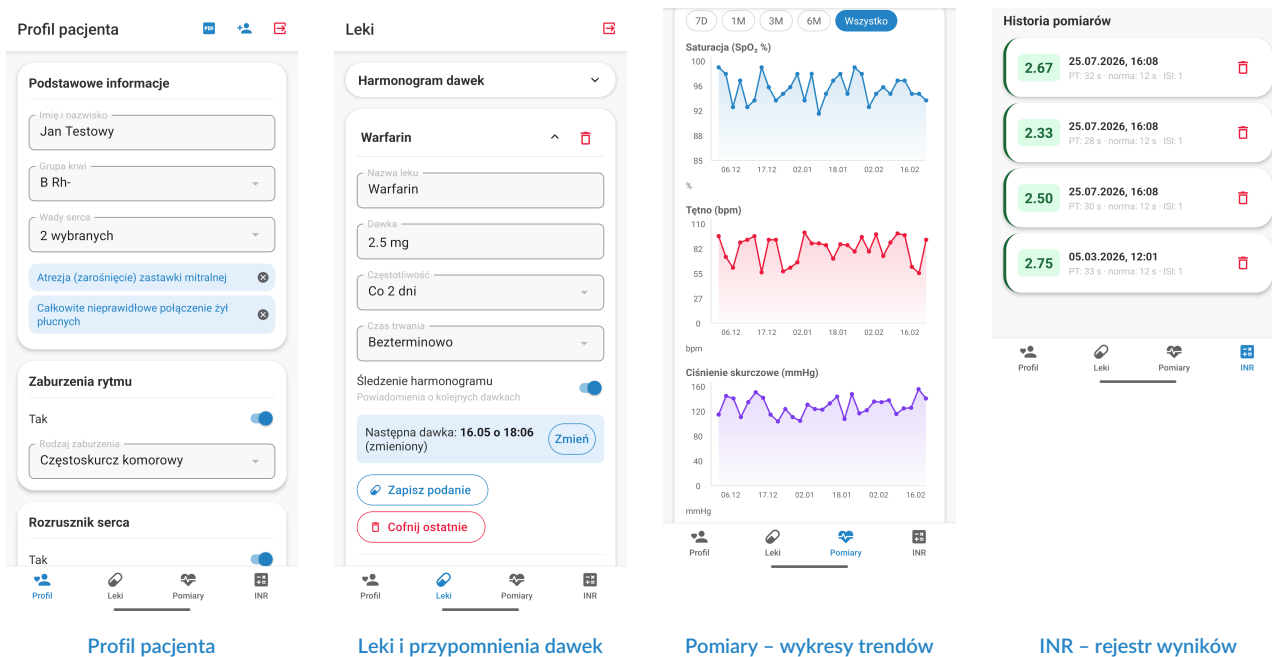
Czego projekt nie obiecuje: poprawy wskaźników klinicznych, skrócenia hospitalizacji ani zastąpienia opieki medycznej. Sukcesem jest dostępne, zrozumiałe i bezpieczne narzędzie, z którego rodziny korzystają na co dzień przy organizacji opieki nad dzieckiem z WWS.

11 Podsumowanie

Aplikacja pacjenta „Wyjątkowe Serca” odpowiada na konkretną potrzebę rodzin dzieci z wrodzonymi wadami serca: uporządkowanie danych o zdrowiu i leczeniu w jednym, mobilnym, bezpiecznym narzędziu. Projekt grantowy obejmuje ukończenie produktu na Androidzie i iOS, publikację w oficjalnych sklepach z aplikacjami, wzmocnienie zgodności z RODO przy danych o zdrowiu oraz dwunastomiesięczne utrzymanie. Aplikacja jest też pomostem do dalszego wsparcia: rodziny, które fundacja pozna dzięki niej, mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

Wnioskowana kwota to **228 400 zł** i składa się z trzech części: 155 100 zł na prace rozwojowe (705 godzin w stawce 220 zł/h), 7 000 zł kosztów stałych okresu prac (prawnik RODO, hosting) oraz 66 300 zł na dwanaście miesięcy utrzymania po wdrożeniu. Sama aplikacja po ukończeniu będzie warta 276 100 zł: 155 100 zł prac z dotacji powiększone o **121 000 zł, które fundacja wniosła już nieodpłatnie** w postaci działającej wersji roboczej (ok. 44% zakresu). Dotacja finansuje wyłącznie prace przyszłe. Inwestycja wzmacnia misję fundacji w obszarze codziennego wsparcia rodziców, w sposób mierzalny, odpowiedzialny i możliwy do kontynuacji po zakończeniu dofinansowania.

Poniższe zrzuty ekranu pochodzą z roboczej wersji aplikacji (Android) przed publikacją w sklepach. Wszystkie widoczne dane są fikcyjne, pochodzą z profilu demonstracyjnego.



Dokument przygotowany jako załącznik merytoryczny do wniosku o dofinansowanie. Nie stanowi pełnej dokumentacji prawnej (DPIA, umowy powierzenia, polityka prywatności stanowiące odrębne dokumenty fundacji) ani dokumentacji technicznej dla zespołu deweloperskiego.

Fundacja Wyjątkowe Serca · aplikacja pacjenta · opis projektu pod wniosek o dotację